Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent11vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5175373-92.2023.8.21.0001/RS

AUTOR: ESTER MARIA WENDT

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de ação condenatória proposta por **ESTER MARIA WENDT** em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA** alegando que a requerente tem diagnóstico de Neoplasia Maligna da Mama (CID C50) e que diante do quadro clínico apresentado, necessita, em caráter de urgência, fazer uso do medicamento OLAPARIBE 300 mg (2 comprimidos de 150mg, via oral, de 12 em 12 horas), sob pena de evolução da doença e morte precoce. Disse que requereu o custeio pelo plano de saúde demandado, que negou cobertura de forma administrativa. Sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Em sede de tutela de urgência, requereu a determinação de custeio/fornecimento imediato do fármaco. Ao final, requereu a procedência da ação para tornar definitivo o dever de cobertura integral ao tratamento requisitado pelo médico. Postulou a concessão da AJG e juntou documentos.

Deferida AJG e concedida a liminar, para "*determinar à ré que forneça à autora o medicamento Olaparibe 300mg, sendo 150mg a cada 12 horas, conforme laudo médico anexado ao evento 1.6, até que sobrevenha decisão judicial em sentido oposto, sob pena de fixação de multa diária para o caso de descumprimento*".

Devidamente citada, a requerida ofereceu contestação. Arguiu preliminar de impugnação ao valor da causa. No mérito, aduziu a existência de cláusula contratual que exclui a cobertura a procedimentos e medicamentos utilizados em contrariedade às prescrições da bula, sendo o chamado tratamento off-label. Afirmou que a diretriz de utilização n. 64, anexa ao rol de eventos em saúde da ANS, estipula requisitos não preenchidos pela parte autora para a cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Sustentou agir em exercício regular de seu direito. Postulou a improcedência do pedido.

Houve réplica.

Em saneamento, afastada a preliminar de impugnação ao valor da causa e registrada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Instadas sobre o interesse na produção de provas, nada foi requerido.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A solução da demanda independe de outras provas, incidindo, por consequência, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Trata-se de ação cominatória pela qual a parte autora pretende seja a requerida obrigada a fornecer o medicamento OLAPARIBE 300 mg, na qualidade de operadora do plano de saúde contratado.

Nessa linha, inegável a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios que norteiam as relações de consumo, disposições que devem ser aplicadas em conjunto com o regramento especial dos plano de saúde (Lei n° 9.656/98).

A autora é cliente dos serviços prestados pela ré, enquadrando-se no conceito de consumidor, nos moldes do artigo 2.º da Lei nº 8.078/90. A parte ré, por seu turno, na condição de prestadora de serviços de seguro saúde, enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3.º, do mesmo diploma legal.

Aliás, tal questão restou sedimentada, a partir da edição da Súmula 60/STJ, que assim dirimiu a controvérsia:

> ***"Súmula 608:*** *Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planode saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."*

No caso dos autos, é incontroversa a relação jurídica mantida entre as partes, devidamente demonstrada pelo cartão do plano de saúde e negativa de custeio do medicamento (evento 1.13).

Com isso, a discussão restringe-se à regularidade da negativa de custeio do procedimento, sob o argumento de que seria inviável o tratamento do paciente com o medicamento, dada as diretrizes constantes da resolução normativa nº 465 da ANS (evento 1.13).

Justificativa

Vimos pela presente esclarecer que medicamento **OLAPARIBE**, não restou atendida a diretriz de utilização especificadas no Rol de coberturas obrigatórias dispostas nas Instruções Normativas 064 da Resolução Normativa 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e para fins da justificativa apresentada, não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-Label) para os pacientes que não apresentam as doenças informadas na bula do medicamento em questão, sendo considerado pela legislação brasileira como tratamento experimental, razão pela qual possui exclusão expressa de cobertura do plano privado de assistência à saúde. . Esclarecemos que tal exclusão está em consonância com o disposto do na Lei Especial nº 9.656/98, que regulamenta os planos privados de assistência à saúde, artigo 10, inciso I, que exclui expressamente o tratamento clínico ou cirúrgico experimental, além da definição dada no art. 17, § 1º, inciso I, letra "C", da Resolução Normativa n.º 465/2021, da Agência Nacional de Saúde – ANS, por tais motivos, não cabe análise de excepcionalidade disposta no 12 e 13 da Lei 9.656/98.

Porto Alegre, 11 de julho de 2023.

Ocorre que a tese de defesa não é suficiente para justificar a negativa administrativa.

Com efeito, é pacífico o entendimento na jurisprudência do STJ no sentido de que não cabe à operadora de plano de saúde delimitar o tipo de tratamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente, mas tão somente estabelecer o tipo de doença que terá cobertura no contrato celebrado entre as partes.

De amparo, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo.
4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.
5. Agravo interno no recurso especial desprovido.
(AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. CÂNCER DE MAMA. RECUSA INADMISSÍVEL. DANO MORAL.
OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais.
Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label).
(AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) 2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura de tratamento gera dano moral, porquanto agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, não se tratando apenas de mero aborrecimento.
3. Verificada ofensa clara a direitos da personalidade, deve ser reconhecida a existência de dano moral.
4. Não se pode reputar, diante do caso concreto, como excessiva a quantia fixada, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Ressalte-se que, no caso em tela, é incontroverso que o contrato vigente possui previsão de cobertura para o tratamento do câncer, inexistindo negativa nesse sentido.

Também é incontroverso que o medicamento requisitado (OLAPARIBE) é de caráter antineoplásico oral, possui registro na ANVISA e é de cobertura obrigatória, estando inserido no rol de eventos em saúde divulgado pela ANS, por força do artigo 10, §4.°, da Lei n. 9.656/98.

Sendo assim, muito embora sua aplicação se qualifique como *off label,* a decisão sobre a eficácia do tratamento para a autora é encargo que compete ao médico da paciente.

Portanto, seguindo a linha da jurisprudência do STJ, deve-se reputar abusiva "*a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental*" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020).

Sobre o tema, cito a posição mais recente da jurisprudência do STJ:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes.
3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp n. 1.653.706/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.046.502/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)
"

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito

pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 2. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 2.016.007/MG, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023, g.n.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONSIDERADO EXPERIMENTAL (OFF-LABEL). ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o conhecimento do segundo agravo interno interposto, pois, em observância ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, só se admite um recurso contra uma única decisão judicial, salvo os embargos de declaração e o recurso extraordinário. Em ocasião anterior assentou-se nesta Corte que "é manifestamente incabível o segundo e o terceiro recursos interpostos pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade" (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.701.567/PE, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019). 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 4. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. 5. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 1.943.693/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023, g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de medicamentos para o tratamento de neoplasia mamária.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.
3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte no sentido de que há obrigatoriedade de fornecimento medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.005.551/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. No caso sub judice, para acolher a pretensão recursal acerca do alegado cerceamento de defesa seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos à doença coberta. 2.1. Igualmente abusiva a exclusão do custeio do tratamento consistente no uso off label de medicamento, o qual era imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.012.180/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente, ainda que se trate da hipótese de tratamento experimental ou off label.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteú do do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.989.283/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

E, ainda, do E. TJRS:

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÍNDROME DE DRESS. FORNECIMENTO DO FÁRMACO IMUNOGLOBULINA HUMANA. DEVER DE COBERTURA VERIFICADO. COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES POSTERIOR À UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. 1. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998. 2. AS COBERTURAS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS POR PLANOS DE SAÚDE SE SUJEITAM A UM ROL MÍNIMO EDITADO PELA ANS, O QUAL NÃO PODE PREVER AS HIPÓTESES DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/98 E NÃO PODE EXCLUIR OU MITIGAR AS HIPÓTESES DO ART. 12 DA MESMA LEI. NÃO OBSTANTE, EVIDENTEMENTE QUE OS CONTRATOS FIRMADOS PODEM ALARGAR O ESPECTRO MÍNIMO DE COBERTURA, INCLUSIVE COBRINDO AS HIPÓTESES DO CITADO ART. 10. 3. NO PONTO, CUMPRE DESTACAR QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE PUBLICADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR É TÃO SOMENTE REFERÊNCIA BÁSICA DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NOS PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NÃO POSSUINDO CARÁTER TAXATIVO. 4. RESSALTE-SE, OUTROSSIM, QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, É FACULTADO AOS PLANOS DE SAÚDE ESTABELECEREM PARA QUAIS PATOLOGIAS IRÃO OFERECER COBERTURA; NO ENTANTO, NÃO PODEM LIMITAR O TRATAMENTO, POIS ESTE CABE SOMENTE AO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE

SEGURADO, CONHECEDOR DAS PECULIARIDADES DE SEU QUADRO CLÍNICO. 5. ASSIM, TEM-SE COMO DEVIDA A COBERTURA POSTULADA (IMUNOGLOBULINA HUMANA), SOBRETUDO PORQUANTO CONCERNENTE A TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA PATOLOGIA INCONTROVERSAMENTE COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE, NÃO CONSISTINDO ÓBICE À COBERTURA EVENTUAL USO OFF LABEL DO FÁRMACO REQUERIDO. 6. DE OUTRO LADO, TANTO A DOUTRINA COMO A JURISPRUDÊNCIA SINALIZAM PARA O FATO DE QUE OS DANOS MORAIS SUPORTADOS POR ALGUÉM NÃO SE CONFUNDEM COM OS TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS COMUNS À VIDA EM SOCIEDADE, ESPECIALMENTE NAS RELAÇÕES NEGOCIAIS. 7. DESSA FORMA, NÃO É QUALQUER DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE SERÁ CAPAZ DE ENSEJAR REPARAÇÃO, PORQUE É NECESSÁRIO ESTAREM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, QUAIS SEJAM: A CONDUTA CULPOSA, O NEXO CAUSAL E O DANO. 8. IN CASU, A SITUAÇÃO RETRATADA CORRESPONDE A MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE DEVE SER VISTO COMO UM PROBLEMA QUE NÃO FUGIU À REGULARIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERFAZEM O CASO, INEXISTINDO EXCEPCIONALIDADE — CUJA COMPROVAÇÃO ERA INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — PARA JUSTIFICAR A REPARAÇÃO MORAL. 9. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, EM ATENÇÃO AO PRECONIZADO PELO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELOS DESPROVIDOS.(Apelação Cível, Nº 50044848120188210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 28-09-2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÂNCER DE MAMA. FÁRMACO XELODA 500MG (CAPECITABINA). TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA DEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE NÃO ACARRETOU PREJUÍZO ÀS PARTES, POIS A QUESTÃO FÁTICA RESTA INCONTROVERSA, RESTANDO SER APRECIADA MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. 2. OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 35 DA LEI 9.656/98, POIS ENVOLVEM TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 469 DO STJ. ASSIM, INCIDE, NA ESPÉCIE, O ARTIGO 47 DO CDC, QUE DETERMINA A INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ALÉM DISSO, SEGUNDO O PREVISTO NO ART. 51, INCISO IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 3. RECONHECIDO QUE O CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES PREVÊ A COBERTURA DE TRATAMENTO DA PATOLOGIA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA, REVELA-SE ABUSIVA A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI DA COBERTURA OS TRATAMENTOS EXPERIMENTAIS. O PLANO DE SAÚDE NÃO PODE SE RECUSAR A CUSTEAR O TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO, POIS CABE A ESTE DEFINIR QUAL É O MELHOR TRATAMENTO PARA O SEGURADO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ. 4. O FATO DE O MEDICAMENTO SER APROVADO PELA ANVISA PARA DETERMINADA DOENÇA NÃO SIGNIFICA QUE SEJA ESSA A ÚNICA PASSÍVEL DE SER TRATADA PELO FÁRMACO, PODENDO O USO OFF LABEL SE REVELAR NECESSÁRIO E ADEQUADO PARA OUTRAS PATOLOGIAS, DEPENDENDO DO ENTENDIMENTO DO MÉDICO ASSISTENTE. 5. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50515808720218210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 31-08-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COLANGIOCARCINOMA. MEDICAMENTO DURVALUMABE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DA MEDIDA. I. DE ACORDO COM A REDAÇÃO DO ART. 300, CAPUT, DO CPC, PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA MOSTRA-SE NECESSÁRIA A PRESENÇA DOS SEGUINTES PRESSUPOSTOS: A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. II. NO CASO CONCRETO, ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA POSTULADA. ACONTECE QUE OS DOCUMENTOS MÉDICOS ACOSTADOS ATESTAM QUE O AGRAVADO FOI DIAGNOSTICADO COM COLANGIOCARCINOMA, SENDO INDICADO TRATAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO DURVALUMABE 1500MG, A CADA 21 DIAS. III. ADEMAIS, O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ESTÁ SUBMETIDO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DA SÚMULA 608, DO STJ, DEVENDO SER INTERPRETADO DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL À PARTE FRACA NA RELAÇÃO, NA FORMA ART. 47, DO ALUDIDO DIPLOMA. DA MESMA FORMA, OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE. IV. AFORA ISSO, QUANDO UM MEDICAMENTO É APROVADO PARA UMA DETERMINADA INDICAÇÃO, NÃO SIGNIFICA QUE ESTA SEJA A ÚNICA POSSÍVEL. ALIÁS, NA MAIORIA DAS VEZES, O USO OFF LABEL DE UM MEDICAMENTO PODE SER ESSENCIALMENTE NECESSÁRIO E CORRETO PARA OUTRAS DOENÇAS, DEPENDENDO TÃO-SOMENTE DO ENTENDIMENTO DO MÉDICO ASSISTENTE. V. DE OUTRO LADO, É ADEQUADA A COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL (ART. 537, CAPUT, DO CPC). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 410, DO STJ. OUTROSSIM, O VALOR ARBITRADO ENCONTRA-SE DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CÂMARA NOS CASOS SEMELHANTES, DEVENDO, NO ENTANTO, SER CONSOLIDADA A MULTA EM 30 DIAS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50637423520228217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 31-08-2022)

Insta consignar, ainda, que a recusa baseada no não preenchimento da Diretriz de Utilização não prospera, já tendo o Min. Raúl Araújo registrado que "***a recusa de cobertura com base somente na ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS para o tratamento (...), sem a indicação, em contrapartida, de terapêutica alternativa eficaz e segura para a enfermidade que acomete o paciente, afigura-se abusiva, aplicando-se aqui a mesma ratio dos medicamentos off label***" (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.031.610/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.).

Ora, se é devida a cobertura a medicamentos que fujam das prescrições do fabricante, o mesmo se pode dizer com relação a medicamentos antineoplásicos que não se enquadrem nas diretrizes de utilização.

Sobre o tema, ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. PIRFENIDONA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).
2. No caso em exame, todavia, o fármaco prescrito pelo médico assistente é um antineoplásico oral, devidamente registrado na ANVISA, com expressa indicação para tratamento de fibrose pulmonar idiopática, sendo abusiva a recusa de cobertura do plano de saúde com base somente na ausência de enquadramento nas diretrizes de utilização da ANS, sem a devida indicação, em contrapartida, de terapêutica alternativa eficaz e segura para a enfermidade que acomete o paciente.

3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar omissão do acórdão embargado e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial interposto pela operadora do plano de saúde, ora embargada.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.031.610/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Outrossim, as limitações contidas nas normativas da ANS não se aplicam aos tratamentos antineoplásicos orais.

Isso porque o próprio Superior Tribunal de Justiça inaugurou a distinção sobre o tema, entendendo que a taxatividade do rol da ANS é indiferente à análise do dever de cobertura das operadoras aos tratamentos neoplásicos.

Cito, por oportuno:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA CITORREDUTORA DE INTERVALO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE OVÁRIO. RECUSA ABUSIVA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).
2. No caso, trata-se de cirurgia para eliminar focos de células cancerosas residuais, vinculados a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). Incidência da Súmula 83/STJ.
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa de cobertura cirúrgica ligada ao tratamento de câncer, tendo em vista o risco à saúde e à vida da paciente.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.945.677/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. RECUSA DE TRATAMENTO DE PACIENTE COM CÂNCER. CARÁTER ABUSIVO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe de 10/04/2017).
2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).
3. No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, no que tange à comprovação do ato ilício e do nexo causal dos danos materiais experimentados pela parte recorrida, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.092.558/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023.)

Como se não bastasse, há robusto acervo técnico, ancorado em notas técnicas do NATJUS, amparando o dever de cobertura do medicamento para neoplasias de mama, em especial "***com mutação de BRCA***", como é o caso da autora (evento 1.6), senão vejamos das Notas n. 126988[1] e 155448[2], de abril e novembro/2023, respectivamente:

"Nota Técnica 155448

Tecnologia: OLAPARIBE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Considerando que a paciente atende aos critérios clínicos para a utilização do mesmo, com probabilidade de aumento do tempo sem progressão da doença e aumento da sobrevida. Considerando que o uso de olaparibe diminuiu a chance recidiva de doença oncológica neste contexto. Considerando que a literatura médico científica atualizada, dá suporte ao uso de OLAPARIBE adjuvante por 1 ano para pacientes com câncer de mama com mutação de BRCA."

"Nota Técnica 126988

Tecnologia: OLAPARIBE

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de carcinoma de mama triplo localmente avançado CONSIDERANDO paciente com mutação BRCA CONSIDERANDO que existem dados científicos comprovando a eficácia do olaparibe nesta indicação. CONCLUI-SE que HÁ DADOS sustentando o uso de OLAPARIBE para tratamento de CÂNCER DE MAMA BRCA mutado"

Dito isso, é caso de confirmar a liminar concedida e reconhecer o dever de cobertura integral da operadora.

Nesse sentido, em última análise:

*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ADENOCARCINOMA GÁSTRICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NIVOLUMAB. ROL DA ANS. TRATAMENTO OFF LABEL. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO. COBERTURA DEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. I. A PARTE AUTORA PRETENDE VER RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM RESSARCIR OS CUSTOS SUPORTADOS PELA FAMÍLIA DO DE CUJUS, RELATIVAMENTE AO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO OPDIVO (NIVOLUMAB), CONSIDERANDO A NEGATIVA DE COBERTURA NA VIA ADMINISTRATIVA, APESAR DO DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA DO ESTÔMAGO (CID C16). II. O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ESTÁ SUBMETIDO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, O ART. 47, DO CDC, DETERMINA QUE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SERÃO INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. IGUALMENTE, DEVE INCIDIR O DISPOSTO NO ART. 51, IV, § 1°, II, DO CDC, SEGUNDO O QUAL É NULA A CLÁUSULA QUE ESTABELEÇA OBRIGAÇÕES CONSIDERADAS INÍQUAS, QUE COLOQUEM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM. III. É POSSÍVEL COBERTURA DE PROCEDIMENTO OU TRATAMENTO QUE NÃO ESTEJA PREVISTO NO ROL DA ANS QUANDO EXISTIR COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE, BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E PLANO TERAPÊUTICO, OU RECOMENDAÇÃO PELA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (CONITEC), OU DE, NO MÍNIMO, 1 (UM) ÓRGÃO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE QUE TENHA RENOME INTERNACIONAL, DESDE QUE SEJAM APROVADAS TAMBÉM PARA SEUS NACIONAIS. IV. NO CASO, HÁ NOTA TÉCNICA DA PLATAFORMA E-NATJUS (NOTA TÉCNICA 178855) FAVORÁVEL À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO POSTULADO EM PACIENTES COM NEOPLASIA MALIGNA DE ESTÔMAGO (CID C16). V. ADEMAIS, O MEDICAMENTO NIVOLUMAB ESTÁ INCLUÍDO NO ROL DA ANS DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS, EM COMBINAÇÃO COM OUTROS FÁRMACOS, CONFORME ANEXO II DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 465/2021, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). **A EXISTÊNCIA DE DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO NÃO AFASTA O DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE, PORQUANTO OS PLANOS DE SAÚDE APENAS PODEM ESTABELECER PARA QUAIS DOENÇAS OFERECERÃO COBERTURA, NÃO LHES CABENDO LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, INCUMBÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE.** VI. ALIÁS, QUANDO UM MEDICAMENTO É APROVADO PARA UMA DETERMINADA INDICAÇÃO, NÃO SIGNIFICA QUE ESTA SEJA A ÚNICA POSSÍVEL, DESCABENDO A ALEGAÇÃO DA REQUERIDA EM NÃO FORNECER OS MEDICAMENTOS PLEITEADOS POR SE TRATAR DE MEDICAÇÃO OFF LABEL. VII. PORTANTO, À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI N° 9.656/98, IMPÕE-SE À OPERADORA DO PLANO SUPORTAR AS DESPESAS DO TRATAMENTO EM QUESTÃO. VIII. DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC, AO JULGAR RECURSO, O TRIBUNAL DEVE MAJORAR OS HONORÁRIOS FIXADOS ANTERIORMENTE AO ADVOGADO VENCEDOR, OBSERVADOS OS LIMITES ESTABELECIDOS NOS §§ 2º E 3º PARA A FASE DE CONHECIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50560416820228210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 13-12-2023)(grifei)*

Nessa conjuntura, a procedência da demanda é medida que se impõe.

DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo ***PROCEDENTES*** os pedidos formulados por **ESTER MARIA WENDT** em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA** paraa, confirmando a tutela de provisória de urgência, **DETERMINAR** à ré que forneça a autora o medicamento Olaparibe 300mg, sendo 150mg a cada 12 horas, conforme laudo médico anexado ao evento 1.6, sob pena de multa para o caso de descumprimento devidamente comprovado nos autos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador do autor, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido, com destinação ao FADEP.

Havendo interposição de apelação no prazo recursal, intime-se o apelado, para, querendo, oferecer contrarrazões. Após, nada mais ensejando intervenção do juízo de primeiro grau, remeta-se ao TJRS. Do mesmo modo, na hipótese de interposição de apelação adesiva, vista à parte contrária para apresentação de contrarrazões, no prazo legal, sendo, após, remetido ao TJRS.

Não havendo interposição de recurso certifique-se o trânsito em julgado e, uma vez recolhidas eventuais custas, arquive-se com baixa.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **CINTIA DOSSIN BIGOLIN, Juíza de Direito**, em 5/3/2024, às 17:42:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10053728611v11** e o código CRC **6e585654**.

---

1. Acesso disponível em <https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:126988:1706733531:ee70aecab579538599b14e58d1bc43314be888e0a082c83a8e51b3f25663b025> ↩
2. Acesso disponível em <https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:155448:1706733531:91527707cceb8335a6f8dd8c6819ffcfb0ce30f03290fa1947a5cf2868f044bc> ↩